



CUIDADOS

La enfermera especialista en salud mental en la gestión del caso de una paciente con esquizofrenia grave



Silvia Díaz-Fernández ^{a,b,c,*}

^a Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Camilo José Cela, Villanueva de la Cañada, Madrid, España

^b Área de Gestión Clínica de Salud Mental-V. Hospital Universitario de Cabueñes (HUCAB), Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), Gijón, Asturias, España

^c Instituto para la Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, Asturias, España

Recibido el 15 de enero de 2021; aceptado el 24 de mayo de 2021

Disponible en Internet el 16 de julio de 2021

PALABRAS CLAVE

Gestión de casos;
Cuidados de enfermería;
Esquizofrenia;
Continuidad de cuidados

Resumen Los programas comunitarios para personas con trastorno mental grave (TMG) con metodología basada en la gestión de casos han mostrado conseguir una elevada adherencia al tratamiento, y una disminución de los ingresos hospitalarios debido a reagudizaciones de los procesos. Es necesaria la continuidad de cuidados a través de una buena relación terapéutica a lo largo de todo el proceso asistencial hasta llegar a la estabilización clínica. El presente caso trata de una mujer con diagnóstico de esquizofrenia con tratamiento inicial en un centro de salud mental y posteriormente en un programa para personas con TMG con gestión de casos. Se realizó inicialmente una valoración enfermera y se elaboró un plan de cuidados en base a la taxonomía North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), Nursing Outcomes Classification (NOC) y Nursing Interventions Classification (NIC). Los resultados obtenidos a lo largo de los años han sido muy positivos, consiguiendo, entre otros objetivos, la estabilización clínica y una vida normalizada.

© 2021 Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

KEYWORDS

Case management;
Nursing care;
Schizophrenia;
Continuity of patient care

The mental health nurse as case manager of a patient with severe schizophrenia

Abstract Community-based programmes for people with severe mental illness (SMI), with a case management methodology, have shown high treatment adherence and a decrease in psychiatric hospitalizations. There is a need for continuity of care through a good therapeutic relationship, maintained throughout the care process until reaching clinical stabilization. The proposed case shows the treatment of a woman with a diagnosis of schizophrenia who began

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: marmotillazz@gmail.com

treatment in a mental health centre and was later referred to a case managed SMI programme. A nursing assessment was carried out from the beginning and a care plan was made based on the NANDA (North American Nursing Diagnosis Association), NOC (Nursing Outcomes Classification), NIC (Nursing Interventions Classification) taxonomy. The outcomes over the years are remarkable, achieving among other objectives not only clinical stabilization but also a normal life.

© 2021 Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción

Los programas comunitarios de continuidad de cuidados y la gestión de casos en salud mental se remonta a los años 70 en EE. UU. tras la reforma de la salud mental. Desde entonces se ha seguido avanzando y mejorando en esta línea aportando cada vez más evidencia sobre sus resultados¹. Según la experiencia en otros países, la enfermera gestora de casos en salud mental, en colaboración con el psiquiatra, coordina los servicios, recursos y tratamientos que el paciente precisa, y vela porque obtenga la asistencia adecuada, acceda y utilice los recursos, a través de un apoyo sostenido, para conseguir acercarse a los objetivos generales, tanto clínicos como rehabilitadores^{2,3}.

Los programas de continuidad de cuidados para personas con trastornos mental grave (TMG) con metodología de gestión de casos han mostrado que favorecen el contacto con los servicios de salud y reducen las hospitalizaciones, ambos problemas frecuentes en estos pacientes^{1,3}.

El Programa de Atención a Personas con Trastorno Mental Grave, ubicado en el Centro de Tratamiento Integral (Área de Salud Mental del Servicio de Salud del Principado de Asturias) se caracteriza por incorporar todas las prestaciones básicas necesarias para el tratamiento integral de la esquizofrenia, permitiendo además, el tratamiento extra-hospitalario con cobertura de 24 h, incluyendo ingresos de cuadros clínicos subagudos (en régimen abierto), atención en hospital de día, atención ambulatoria y domiciliaria, según las necesidades del paciente, en cada momento y asegurando así la continuidad asistencial^{3,4}.

Al ser un programa multicomponente, los tratamientos que se ofrecen son: farmacológico, psicológico (individual y grupal), rehabilitación cognitiva, entrenamiento en habilidades de la vida diaria, ocio activo, psicoeducación, etc. Y es llevado adelante por un equipo multidisciplinar compuesto por psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeras, terapeutas ocupacionales, técnicas de cuidados auxiliares de enfermería y personal administrativo^{3,4}.

Conforme se describe en el programa, una de las figuras básicas e imprescindibles es la «gestora de caso» o tutora (que en Asturias es asumido por una enfermera con formación especializada en salud mental), definida como la persona encargada de coordinar, integrar y asignar atención individualizada a personas con TMG mediante el contacto continuo³, y siendo la responsable, junto con el psiquiatra, de todo el proceso de atención al paciente, habiendo demostrado su efectividad para el cumplimiento del plan

terapéutico. Y siempre trabajando dentro del equipo multidisciplinar que atiende al paciente para favorecer la adherencia al tratamiento y garantizar la continuidad de cuidados.

Descripción del caso

Antecedentes personales

Mujer de 51 años, con una hija de 20 años con la que ya no convive. Separada. El padre y el hermano se suicidaron. Vive con su madre. Diagnosticada de esquizofrenia paranoide en 1991. Conocida del centro de salud mental (CSM) desde entonces, precisando varios ingresos en la unidad de hospitalización psiquiátrica (UHP). Trabaja como limpiadora a tiempo parcial.

Durante años en el CSM sufrió numerosas descompensaciones psicopatológicas, varias de ellas relacionadas con el abandono del tratamiento farmacológico e incluso de los contactos con el centro, que cursaron con intensa ideación delirante de perjuicio (familia, vecinos) y, en ocasiones, con heteroagresividad. En las etapas de estabilidad muestra un relativo buen rendimiento psicosocial, aunque con déficit en las relaciones sociales, y escasa conciencia de enfermedad.

Evolución

En 2009 pasa a tratamiento en el programa para TMG, con una gravedad clínica importante: impresión clínica global (ICG-G) de 6 al comenzar (La ICG-G indica la gravedad del cuadro clínico, con una escala de Likert de 7 valores que va desde 1 (no enfermo), hasta 7 (extremadamente enfermo)).

Inicialmente estuvo ingresada en régimen hospitalario abierto de 24 h; posteriormente (2010), y tras clara mejoría, pasó a hospital de día, y tras 2 años en hospital de día con buena evolución pasa a seguimiento, acudiendo solamente a consulta con su psiquiatra y enfermera (2013). Mantiene tratamiento con antipsicótico inyectable intramuscular de larga duración, con elevada efectividad y tolerabilidad.

Valoración del caso en el momento actual

En las diversas entrevistas mantenidas, al principio una vez por semana, distanciándose a una por mes (en su etapa de

seguimiento), se recopilan los datos y se trabajó siguiendo los patrones funcionales de Salud de Marjory Gordon:

Percepción-manejo de la salud

Actualmente ha incrementado conciencia de enfermedad, con plena adherencia al tratamiento este tiempo (acudiendo a inyectarse y a consultas puntualmente). Verbaliza estar satisfecha con su evolución y situación actual, no sintiéndose «medicada» ni «enferma» y pudiendo llevar adelante el estilo de vida que desea.

Nutricional-metabólico

El peso se mantuvo durante todo este tiempo, oscilando entre 74,5 al principio a 73 en el momento actual. Mantiene la dieta pautada, baja en grasas.

Eliminación

La paciente presenta riesgo de estreñimiento debido entre otras causas al poco movimiento que presenta y a la medicación.

Actividad-ejercicio

Realiza ejercicio moderado (paseos). Continúa trabajando sin problemas, además de realizar las tareas domésticas.

Sueño-descanso

Sin problemas.

Cognitivo-perceptual

En el momento actual apenas presenta síntomas positivos: sin alucinaciones auditivas.

Autopercepción-autoconcepto

En estos momentos tiene percepción de enfermedad. No muestra sentimientos de minusvalía ni de falta de utilidad.

Rol-relaciones

Tiene un reducido círculo de contactos sociales (una amiga, algún vecino y su madre, apoyo importante durante todo el proceso).

Sexualidad-reproducción

La prolactina disminuyó de 36,2 a 23,1, volviendo a menstruaciones regulares. Mantiene relaciones esporádicas seguras.

Adaptación-tolerancia al estrés

Verbaliza estar satisfecha con su evolución y situación actual. No muestra preocupación ni tampoco refiere nerviosismo.

Valores y creencias

Sin problemas.

Planificación y ejecución de los cuidados

Tras la valoración inicial se plantearon los objetivos junto al paciente y la familia, estableciéndose un plan de cuidados individualizado. En la [tabla 1](#) se resumen los diagnósticos enfermeros empleando la taxonomía NANDA⁵, los criterios de resultado (NOC)⁶ e intervenciones (NIC)⁷ prioritarias trabajadas.

Evaluación de los resultados/seguimiento

La ICG-G al inicio de tratamiento era de 6 y a los 10 años de 3, disminuyendo significativamente. No tuvo ingresos psiquiátricos en este periodo. Orientada en las 3 esferas, con leve suspicacia y rotulación paranoide del entorno, con moderada crítica de la temática delirante de perjuicio. Persisten leve apatoabulia y tendencia al aislamiento, en lo que se continúa trabajando. Apenas efectos adversos. Sin alteraciones del ritmo sueño/vigilia ni del apetito. Eutímica. Discurso coherente y relativo buen contacto.

Discusión e implicaciones para la práctica clínica

Desde el punto de vista enfermero se valoró al paciente y se diseñó un plan de cuidados individualizado permitiéndonos trabajar aquellos aspectos clave para su recuperación. Se analizó la situación del paciente y de su entorno y, a través de la valoración enfermera, se detectaron las necesidades específicas a trabajar y especialmente aquellas derivadas de su trastorno mental. Los objetivos fueron fundamentalmente: mejorar la implicación social; alcanzar un buen nivel de autocuidado; conseguir una adecuada autoestima, tener motivación, controlar los síntomas y tener autocontrol del pensamiento distorsionado, así como prevenir y evitar recaídas e ingresos hospitalarios^{3,8,9}.

Los programas de continuidad de cuidados en salud mental, con gestión de casos, permiten establecer una relación de confianza, imprescindible para mejorar la adherencia al tratamiento³, y así establecer objetivos y trabajar intervenciones específicas y efectivas. La complejidad y diversidad de cuidados enfermeros con pacientes de salud mental hace cada vez más necesario y evidente trabajar usando un lenguaje enfermero para homogeneizar todas y cada una de las intervenciones y poder ofrecer al paciente la continuidad de dichos cuidados^{8,9}.

Hay que destacar también que la efectividad de la gestión de casos en el ámbito de la salud mental no dispone de evidencias sólidas en nuestro país como tal, pues las evaluaciones llevadas a cabo han sido sobre modelos específicos¹¹;

Tabla 1 Interrelación entre etiquetas NANDA, NOC y NIC presentada tras valoración del paciente

NANDA	NOC	RI	RF	NIC
00078 Gestión ineficaz de la salud	1608 Control de síntomas			5602 Enseñanza: proceso de enfermedad
	160801 Reconoce el comienzo del síntoma	1	4	5616 Enseñanza: medicamentos prescritos
	160806 Utiliza medidas preventivas	1	4	2380 Manejo de la medicación
	160811 Refiere control de los síntomas			
00168 Estilo de vida sedentario	1209 Motivación			0200 Fomento del ejercicio
	120907 Mantiene una autoestima positiva	2	4	4360 Modificación de la conducta
	120912 Finaliza las tareas	1	4	
00015 Riesgo de estreñimiento	0501 Eliminación intestinal			4120 Manejo de líquidos
	050101 Patrón de eliminación	2	4	0430 Control intestinal
00153 Riesgo de baja autoestima situacional	1205 Autoestima			5400 Potenciación de la autoestima
	120501 Verbalizaciones de autoaceptación	2	4	5230 Mejorar el afrontamiento
	120502 Aceptación de las propias limitaciones	2	3	
00193 Descuido personal	0313 Nivel de autocuidado			1800 Ayuda con el autocuidado
	031305 Mantiene la higiene personal	2	5	4360 Modificación de la conducta
	031310 Realiza tareas domésticas	1	4	
00065 Patrón sexual ineficaz	1905 Control del riesgo: Enfermedades de transmisión sexual			5622 Enseñanza: relaciones sexuales seguras
	190510 Utiliza estrategias para evitar la transmisión de enfermedades de transmisión sexual	3	5	
00128 Confusión aguda	0900 Cognición	2	4	6450 Manejo de las ideas delirantes
	090003 Atiende	1	4	6510 Manejo de las alucinaciones
	090011 Toma decisiones apropiadas			
00146 Ansiedad	1402 Autocontrol de la ansiedad	1	3	5820 Disminución de la ansiedad
	140206 Planifica estrategias de superación efectivas	1	4	6040 Terapia de relajación
	140207 Utiliza técnicas de relajación para reducir la ansiedad			
00060 Interrupción de los procesos familiares	2602 Funcionamiento de la familia	1	5	7150 Terapia familiar
	260209 Se adapta a crisis inesperadas			7110 Fomentar la implicación familiar
00199 Planificación ineficaz de las actividades	1614 Autonomía personal	1	5	4410 Establecimiento de objetivos comunes
	161411 Participa en las decisiones de los cuidados de salud	2	4	1805 Ayuda con el autocuidado:
	161412 Expresa satisfacción con las elecciones de la vida			
00150 Riesgo de suicidio	1403 Autocontrol del pensamiento distorsionado.	1	4	5330 Control del estado de ánimo
	140307 Solicita ratificación de la realidad	2	5	6340 Prevención del suicidio
	1206 Deseo de vivir			6650 Vigilancia
	120601 Expresión de determinación de vivir			8190 Seguimiento telefónico
00053 Aislamiento social	1503 Implicación social	1	4	6610 Identificación de riesgos
	150302 Interacción con vecinos	1	5	
	150303 Interacción con miembros de la familia	1	3	5100 Potenciación de la socialización
	150304 Interacción con miembros de grupos de trabajo			4362 Modificación de la conducta: habilidades sociales

AIVD: actividades instrumentales de la vida diaria; NANDA: North American Nursing Diagnosis Association; NIC: Nursing Interventions Classification; NOC: Nursing Outcomes Classification; RF: resultado final; RI: resultado inicial.

y en el caso de la salud mental, la especialidad no se articula en el modelo de gestión de casos exactamente como en otros países, donde existe una especialización dentro del modelo de gestión de casos. Además, al ser un equipo multidisciplinar el que trabaja con el paciente de manera integral, no se puede aventurar que los resultados de efectividad obtenidos sean debidos a la intervención única y exclusiva de las enfermeras.

Como conclusión se destaca el papel fundamental que desempeña la enfermera, como gestora de caso, dentro de un equipo multidisciplinar, realizando un plan de cuidados en una paciente compleja, y llevándolo a la práctica con efectividad, permitiendo mejorar los resultados en salud al lograr continuidad de la atención¹⁰, facilitando la toma de decisiones junto con al paciente y el resto de equipo con calidad.

Conflicto de intereses

La autora declara no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

1. Dieterich M, Irving CB, Bergman H, Khokhar MA, Park B, Marshall M. Intensive case management for severe mental illness. *Cochrane Database Syst Re.* 2017; <http://dx.doi.org/10.1002/14651858>.
2. Kanter J. Clinical Case Management: Definition, Principles Components. *Psychiatr Serv.* 1989;40:361–8, <http://dx.doi.org/10.1176/ps.40.4.361>.
3. Díaz-Fernández S, Frías-Ortiz DF, Fernández-Miranda JJ. Estudio en imagen en espejo (10 años de seguimiento y 10 de pretratamiento estándar) de ingresos hospitalarios de personas con esquizofrenia grave en un programa comunitario con gestión de casos. *Rev Psiquiatr Salud Ment.* 2019; <http://dx.doi.org/10.1016/j.rpsm.2019.04.004>.
4. Díaz-Fernández S, Frías-Ortiz DF, Fernández-Miranda JJ. Suicide attempts in people with schizophrenia before and after participating in an intensive case managed community program: A 20-year follow-up. *Psychiatry Res.* 2020;287:112479, <http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2019.112479>.
5. NANDA International. *Diagnósticos Enfermeros. Definiciones y Clasificaciones 2018-2020.* Barcelona: Elsevier; 2018.
6. Moorhead S, Johnson M, Maas ML, Swanson E. *Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC).* 6.ª edición Barcelona: Elsevier; 2018.
7. Butcher H, Bulechek G, Dochterman J, Wagner C. *Clasificación de intervenciones de enfermería. (NIC).* 7.ª edición Barcelona: Elsevier; 2019.
8. Frauenfelder F, van Achterberg T, Müller-Staub M. Documented Nursing Interventions in Inpatient Psychiatry. *Int J Nurs Knowl.* 2018;29:18–28, <http://dx.doi.org/10.1111/2047-3095.12152>.
9. Frauenfelder F, van Achterberg T, Müller Staub M. Nursing diagnoses related to psychiatric adult inpatient care. *J Clin Nurs.* 2017;4:63–75, <http://dx.doi.org/10.1111/jocn.13959>.
10. Miguélez-Chamorro A, Casado-Mora MI, Company-Sancho MC, Balboa-Blanco E, Font-Oliver MA, Román-Medina Isabel I. Enfermería de Práctica Avanzada y gestión de casos: elementos imprescindibles en el nuevo modelo de atención a la cronicidad compleja en España. *Enferm Clin.* 2019;29:99–106, <http://dx.doi.org/10.1016/j.enfcli.2018.08.005>.
11. Morales-Asencio JM. Gestión de casos y cronicidad compleja: conceptos, modelos, evidencias e incertidumbres. *Enferm Clin.* 2014;24:23–34, <http://dx.doi.org/10.1016/j.enfcli.2013.10.002>.